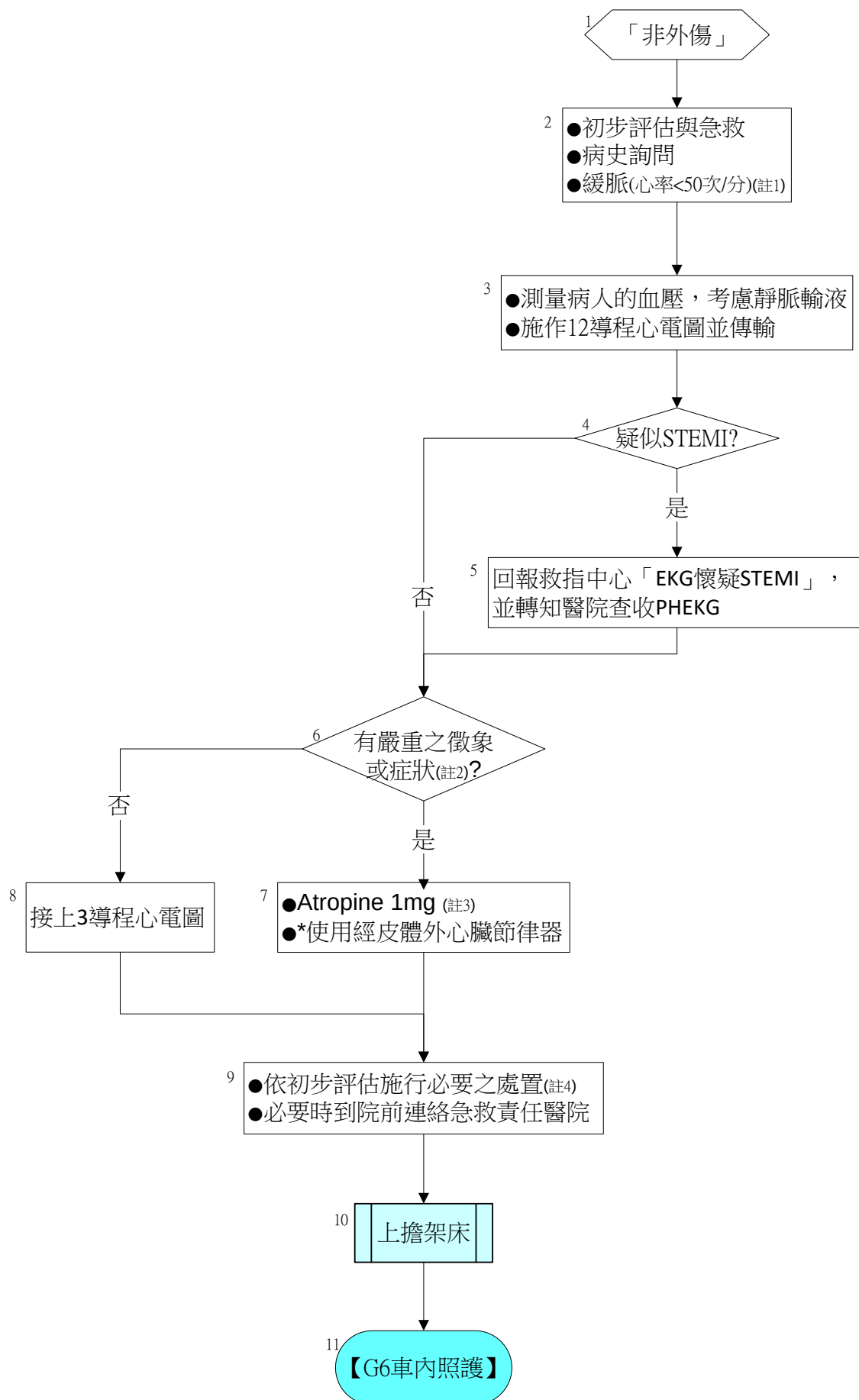


M8 **P**嚴重緩脈（Bradycardia）

程 序



要 旨

- 一、本程序建議之處置僅限 EMT-P 操作。EMT2請依通用程序（G）處理此類傷病人。
- 二、EMTP在初步評估時檢查脈搏若發現傷病人（嬰兒與新生兒除外）脈搏次數每分鐘 < 50次，即建議使用本程序。
- 三、醫學上定義脈搏每分鐘<60次為緩脈。此時傷病人可能有無力感、心悸感或昏厥感，但通常不須用到本程序建議之處置。與嚴重之徵象或症狀相關的緩脈，往往是<50次。
- 四、緩脈常見的原因為低血氧、心肌梗塞/缺氧、毒藥物中毒(例如：鈣離子通道阻斷劑、毛地黃、有機磷)、電解質異常(例如：高血鉀)，建議須將以上列入重要鑑別診斷並優先處置，或做好防護與除污。

註 解

註1>

- 一、緩脈應注意A-B-C，獲得相關病史及準備急救器材。
- 二、每分鐘<60次則可定義為緩脈，依據AHA 2020年ACLS指引，每分鐘<50次之緩脈需予以積極監測與處置。

註2>

嚴重之徵象或症狀是指--急性心臟衰竭、休克徵候、急性意識改變、低血壓、缺血性胸痛共五大徵候。

註3>

- 一、STEMI病人不可給予Atropine。
- 二、Atropine 1 mg iv push，每3~5分鐘給一次，最多總共給3次。

註4>

參考「M7疑似缺血性胸痛」流程。